



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : نورالهدى مصطفى سيد حسن
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : الساحل
رقم البطاقة : 27507260103023 رقم التليفون : 01155894672
العنوان : ممممممممممم
العمر (تاريخ الميلاد) : 26-07-1975 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نورالهدى مصطفى سيد حسن National ID: 27507260103023	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


 جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحمل الشخصية

لور الهدى
 مصطفى سيد حسن
 ١٨ ش محمد الشناوى
 الساحل - القاهرة

١٩٧٥/٠٧
 ٢٧٥.٧٢٦.١.٣.٢٣
 LA1131539


 ٢.٢٥/٠٢ ٢٧٥.٧٢٦.١.٣.٢٣
 دكتورة في الحقوق - محامية بالمعاش
 أنثى مسلمة أرملة
 البطاقة مارية حتى ٢.٢٢/٠٢/٠٨







النقابة العامة للمحامين
مشروع الرعاية الصحية
للمحامين وأسرتهم

شهادة

تشهد النقابة العامة للمحامين بأن الأستاذة / نور الهدى مصطفى سيد حسن
المحاماة

المقيدة تحت رقم / 183979

غير مشتركة بمشروع العلاج بالنقابة العامة للمحامين ولم يتم الاستفادة منه لهذا
العام 2026.

وذلك

لتقديمها لأي جهة يرغب بها دون أدنى مسئولية على النقابة العامة للمحامين .

عضو المجلس

التوقيع /

التاريخ / 2026/6/27



Name: MR. :	نور الهدى مصطفى سيد حسن 10608	
Detailed Medical Report		
		السيد
تخية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	
	رقم طبي:	
إيماء للطلب المقدم من بقسم:		
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
51 yrs , not DM or HTN , No major operation , +ve FH mother BC , nullipara , the condition start by vaginal bleeding pt sought medical advice to do US , CT 4/2026 --> Rt adnexal complex loculated 8.3x4.6x8.6 cm likely neoplastic CT Chest --> free MRI Pelvis --> Rt adnexal / ovarian complex cystic lesion with minimal ascites 4.4x9.2x5.7 cm CA125 1322 Colonoscopy --> 3rd degree of piles for Surgical consultation 51 yrs , not DM or HTN , No major operation , +ve FH mother BC , nullipara , the condition start by vaginal bleeding pt sought medical advice to do US , CT 4/2026 --> Rt adnexal complex loculated 8.3x4.6x8.6 cm likely neoplastic CT Chest --> free MRI Pelvis --> Rt adnexal / ovarian complex cystic lesion with minimal ascites 4.4x9.2x5.7 cm CA125 1322 Colonoscopy --> 3rd degree of piles for Surgical consultation 8/2026 CANCER OVARY : -CT CAP + TM -STAGE 1 C3 , FOR ADJUVANT TAXOL , CARBO X 4-6 CYCLES -CONSIDER ER, PR AS LOW GRADE SEROUS MAY BENIFIT FFROM HORMONAL TTT CT AND TM ,,,REQ		
تحريرا في ,		
	الوقت :	
		التاريخ : 19-09-2026
		الطبيب المعالج : mohamed ismael
يعتمد ,		

**GUSTAVE/
ROUSSY-**
INTERNATIONAL
EGYPT

Date Of Submission:

Date Of MDT:

08/23/2026 17:19:04

CP
A - CP

Medical Report

Patient Name :

نور الهدى مصطفى سيد حسن

Age :

51 Y

Sex :

☐ Male ☒ Female

Comorbidity :

NAD

ID No. :

10608

Telephone :

01006029323

Family History :

27507260103023

Marital Status :

☒ Married ☐ Divorced ☐ Single

Menopausal Status :

post

Reason of MDT :

post op

MDT name::

Medical Report

Diagnosis :

Notes :

History:

MRI>>LARGE RT. ADENXAL MULTILOCULAR COMPLEX CYSTIC LESION IRREGULAR NODULAR ENHANCING SEPTATIONS SPACES WITH ENHANCING SOFT TISSUE COMPONENT 4.4*9.2*5.7 CM
LT ADENXAL BILOCULAR CYST WITH NO ENHANCING INTERNAL SEPTATIONS OR MURAL NODULE 2.2*3*3 CM WITH MINIMAL ASCITES
*CT CAP>>RT ADENXAL COMPLEX MULTILOCULATED CYSTIC LESION THICKENED SETAE WITHY ENHANCING SOFT TISSUE COMPONENT 8.3*4.6*8.6 CM
*TRANS VAGINAL US>> RT OVARY ENLARGED 8*4*5 CM WITH SEVERAL CYSTIC SPACES SEPARATED WITH OVARIAN STOMA
ptn underwent TAH +BSO+Appendectomy
rt ovary
invasive low grade serous carcinoma of rt ovary
ascitic fluid :positive for malignant cells

Investigations:

Recommendations:

MDT DECISION:

-CT CAP + TM
STAGE 1 C3 , FOR ADJUVANT TAXOL , CARBO X 4-6 CYCLES
CONSIDER ER, PR AS LOW GRADE SEROUS MAY BENIFIT FFROM HORMONAL TTT

Specialty

Surgery

Pathology

Radiology

CP
1/3

CP
1/3

Patient Name	نور الهدي مصطفى سيد	Case No.	344063
Sex/Age	Female 51 Y	Patient No.	25169
Registered Date	25/7/2026 03:58:07 PM	Referred By Dr.	Surgery
Validation Date	16/8/2026 03:40:01 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	16/8/2026 03:51:58.PM	Pathology No.	2342/26

Pathology Report

Clinical Data: Right Ovarian Mass With Increased CA125.

Nature of specimen: 1. Ascitic Fluid For Cytology, 2. Pan Hysterectomy& 3. Omentectomy.

Gross Examination:

Specimen received in three containers:

Container 1:

Received 10 mL of hemorrhagic fluid submitted for cytological examination.

Container 2 (TAH + BSO):

Received a total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy specimen:

- Uterus measures $7 \times 5 \times 3.5$ cm.
- Cervix measures 3 cm in length and 2.5 cm in diameter.
- Endometrial thickness is 0.2 cm.
- Myometrium measures 2.5 cm in maximum thickness and shows multiple intramural and subserosal leiomyomata up to 1×1 cm.
- The right ovary measures $9 \times 6 \times 6$ cm and is almost completely replaced by a partly solid, partly cystic grey-white mass. On cut section, the cystic spaces are filled with hemorrhagic fluid and show multiple papillary projections measuring up to 1.5 cm.
- Right fallopian tube measures 7 cm in length.
- Left ovary measures $3 \times 2 \times 0.8$ cm and is grossly unremarkable.
- Left fallopian tube measures 7 cm in length.

Representative sections are submitted as follows:

- 1&2: Endometrium & myometrium.
- 3: Leiomyoma.
- 4: Cervix.
- 5-9: Right ovarian mass.
- 10: Right fallopian tube.
- 11: Left ovary.
- 12: Left fallopian tube.



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	نور الهدي مصطفى سيد	Case No.	344063
Sex/Age	Female 51 Y	Patient No.	25169
Registered Date	25/7/2026 03:58:07 PM	Referred By Dr.	Surgery
Validation Date	16/8/2026 03:40:01 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	16/8/2026 03:51:58 PM	Pathology No.	2342/26

Container 3 (Omentum):

Received an omental tissue measuring 30 × 16 cm. The external surface is grossly unremarkable with no identifiable nodules. Representative sections are submitted in (13–16).

Dr. Aya Ezzat.

Microscopic Examination:

Sections from the right ovarian mass show an invasive epithelial neoplasm composed of complex branching papillae and infiltrative glands lined by relatively uniform atypical cuboidal to columnar cells exhibiting mild to moderate nuclear atypia and infrequent mitoses, set in a desmoplastic fibrous stroma. Adjacent areas show a serous borderline tumor with hierarchical papillary architecture and epithelial stratification without stromal invasion. The ovarian capsule is intact and the external ovarian surface is free of tumor deposits.

The right fallopian tube is free of tumor deposits and shows no evidence of serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC). Multiple paratubal simple cysts are present.

The left ovary and fallopian tube are free of tumor deposits. Multiple paratubal simple cysts are identified. Sections from the uterus show multiple leiomyomata with no evidence of malignancy. The cervix shows chronic nonspecific cervicitis with squamous metaplasia involving both the surface epithelium and endocervical glands, without tumor involvement.

Sections from the omentum show mature fibroadipose tissue with no evidence of metastatic tumor. Cytological examination of the ascitic fluid is positive for malignant cells.

Diagnosis:
Right Ovarian Mass (TAH + BSO, Omentectomy And Ascitic Fluid):

- Invasive low-grade serous carcinoma of the right ovary arising in a background of serous borderline tumor.
- Ovarian capsule intact, with no ovarian surface deposits.
- Right fallopian tube: negative for tumor deposits and negative for STIC, multiple paratubal simple cysts.
- Left ovary and left fallopian tube: free of tumor deposits; multiple paratubal simple cysts.
- Uterus: free of tumor deposits with multiple leiomyomata.
- Cervix: free of tumor deposits; with chronic nonspecific cervicitis with squamous metaplasia.
- Omentum: free of tumor deposits.
- Ascitic fluid cytology: Positive for malignant cells.

Signature

Dr. Rana Elsaeed.



غرفة رقم (4) - الدور الاول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

NAME: nourelhuda Mostafa sayed

DATE: 23/8 /2026

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Average in size (15cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echo pattern with smooth surface.
- No hepatic focal lesions or intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with multiple stones seen inside each bout 10mm
- The wall is not thickened.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size, homogenous.

Kidneys: -

- Both are average in size, shape and echogenicity
- No stones or dilated pelvicalyceal system
- No gross lesion

Para-aortic and pancreatic area: show no gross abnormalities.

No ascites

Urinary Bladder: -

- Not distended enough however no stones or diverticular out pouching

Opinion:

Calcular GB

Hysterectomy

Dr. Nermeen Ramadan.MD

NAME: norelhoda mostafa

DATE: 16/8 /2026

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Average in size (15cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echopattern with smooth surface.
- No hepatic focal lesions or intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with few stones seen inside each about 10mm
- The wall is not thickened.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size, homogenous.

Kidneys: -

- Both are average in size, shape and echogenicity
- No stones or dilated pelvicalyceal system
- No gross lesion

Para-aortic and pancreatic area: show no gross abnormalities.

No ascites

Urinary Bladder: -

- Average capacity with no stones or diverticular out pouching

Opinion:

TAH-BSO

Calcular GB

Colonic gaseous distention

Best regards
Dr. NERMEEN RAMADAN FEBR, MD

1.7.1

Name: Nour Al Hoda Moustafa Sayed	Pat. ID: 14269013
Procedure: pelvic vessels Doppler	Date: 21/04/2026

TRANSVAGINAL ULTRASONOGRAPHY REVEALED

- Normal filling of the urinary bladder with no stones, masses or diverticulae.

The Uterus:

- Dimensions: 7.5 cm x 4.5 cm x 4 cm
- Central in the pelvis.
- Non-gravid.
- Homogenous myometrium with no focal lesions.
- Central regular endometrial line, measuring 4 mm in thickness.

The Ovaries and adnexa:

- *The right kidney appears enlarged, measuring about (8 cm x 4 cm x 5 cm), with several cystic spaces separated by ovarian stroma. No definite mass lesions seen and the stroma is vascular on Doppler evaluation (the right ovary is not seen separate from the lesion)*
- Normal size and sonographic appearance of the right kidney

The Douglas Pouch:

- No localized or free fluid collection.

Conclusion:

Right ovarian lesion as described, for further MRI evaluation

Dr. Basem Robeel, MSc, FRCR

Consultant radiologist

Not Approved

Visit Number: 61126508248

Patient Name: نور الهدى مصطفى سيد

Age / Sex: 51 year / Female

Patient ID: 2129569943

Client Name: نقابة المحامين - القاهرة

Referred by Prof: محمود السقا

Exam Date: 15 Apr 2026

Printed: 18 Apr 2026 06:50:22 PM

CT

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the abdomen and pelvis were obtained followed by multiplanar reconstruction of the source images. IV and oral contrast was used.

CLINICAL HISTORY: excessive vaginal bleeding for last 6 days start from 2 months. Patient with right iliac fossa pain (undefined ovarian lesion by physician), lower abdominal pain, alternating bowel habits. Cholecystectomy.

FINDINGS:

- Right adnexal showing complex multi-loculated cystic lesion showing thickened septae with enhancing soft tissue component. It measures about 8.3 x 4.6 x 8.6 cm at maximum axial and CC dimension.
- No gross left adnexal masses or cysts.
- The liver is average in size showing homogenous CT density and enhancement with no focal lesions.
- Patent and homogeneously opacified portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Gall bladder shows few radio-dense stones. No mud.
- Normal CT appearance of the spleen with small splenule, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- No abdominal or pelvic pathologically enlarged lymph nodes.
- No ascites.
- Scanned lung bases are clear.

الأحمد محمد شرف الدين
لبيب مقيم الجراحة العامة والناظم

د/عمر لطفي / استشاري

شركة ريف البرد
لاستشارات طبية
وخدمات طبية
وإدارة
الناظم



الهندسين 00 شارع عبدالمنعم رياض، برج الأطباء، الدور ٢
شبرا 09 شارع شبرا
منصر الجديدة 17 شارع الميرغني
فيصل محطة النحاس
الشيخ زايد كائنتال بيزنس بارك، مبنى B5، الدور ٣
المعادي ٢٠ شارع الجزائر
مدينة نصر ٢٢ شارع عبد الرزاق السنهوري



Visit Number: 61126508248
Patient Name: نور الهدى مصطفى سيد
Age / Sex: 51 year / Female
Patient ID: 2129569943

Client Name: نقابة المحامين - القاهرة
Referred by Prof: محمود السقا
Exam Date: 15 Apr 2026
Printed: 18 Apr 2026 06:50:22 PM

CT

OPINION:

- Right adnexal complex cystic lesion, likely of neoplastic aetiology dedicated contrast enhanced MRI study.
- Calcular gall bladder.

Dr. Amr Ali

Professor. Sally Emad-Eldin, MD



القاهرة: ٥٥ شارع عبد المنعم رياض، برج الأطباء، الدور ٢
شبرا: ٥٩ شارع شبرا
مصر الجديدة: ٦٧ شارع الميرغني
قنصل: محطة التعاون
الشيخ زايد: كاستال بيرنس بارك، مبنى B5، الدور ٢
المعادي: ٣٠ شارع الحرار
مدينة نصر: ٢٢ شارع عبد الرزاق السنهوري

Patient's Name: Nour Al-Huda Mustafa Said Hassan
Date: 2026-09-05
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS WITH CONTRAST

TECHNIQUE: Multi slice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis were obtained followed by multiplanar reconstruction of the source images. I.V contrast administration.

FINDINGS:

Compared to the previous study dated 9-7-2026, the current study showed:

ICHEST:

- No pulmonary masses or nodules.
- No cavitary lesions or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- Normal cardiac size .

II ABDOMEN AND PELVIS:

- Status post TAH-BSO showing clear operative bed with no residual/ recurrent masses/ collection.
- The liver is average in size showing homogenous CT density with no enhancing focal lesions or biliary radicles dilatation.
- The gall bladder still shows few stones within.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas and both kidneys.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- No appreciable time interval changes regarding the few previously seen left external iliac lymph nodes largest measuring 12 x 11 mm.
- No free collection.

THE SCANNED SKELETON:

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- Status post TAH-BSO showing clear operative bed with no evidence of residual/ recurrent operative bed masses/ collection.
- Stationary course regarding the rest of the study.

Dr.Assem Ahmed

Dr.Assem Ahmed

Dr.sherif Wagdy